

vor dem jeweiligen Berichtsjahr verstorben sind, wurden in der Prävalenzberechnung nicht berücksichtigt. Die Aufgreifkriterien beruhen auf ICD-10-GM-kodierten Diagnosen und aus dem stationären Bereich:

162 (Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung) wurde nicht aufgegriffen, da sie sich sowohl im klinischen Bild (den für Schlaganfälle typischen neurologischen Ausfallerscheinungen) als auch durch den geringeren Grad der Beeinträchtigung und die meist folgenlose Ausheilung vom Schlaganfall unterscheidet. Es wurden Fälle in allen Altersgruppen ohne Beschränkungen zur Prävalenzberechnung aufgegriffen und dabei alle Personen der Versichertengrundgesamtheit berücksichtigt. Die Kriterien wurden jeweils in allen Quartalen des Berichtsjahres angelegt, wobei ausgehend von dem betrachteten Quartal jeweils 39 Quartale zurückgeblickt wurde, um insgesamt einen Analysezeitraum von 40 Quartalen für 10-Jahres-Prävalenzen zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Anzahl der erkrankten Personen und damit des Zählers der Prävalenzberechnung wurden

Es wurde für Schlaganfall adaptiert, um für jedes Berichtsjahr Krankheitshäufigkeiten für die gesamte Bevölkerung Deutschlands auf Ebene der 96 Raumordnungsregionen für Schlaganfall zu schätzen.

Bei der Hochrechnung der Prävalenzen werden aus Gründen der Modellstabilität einzelne Altersgruppen in breitere Altersklassen zusammengefasst, sodass nicht immer eine Prävalenz für jede 5-Jahres-Altersgruppe vorliegt. Um eine Stratifizierung auf dieser Detailebene zu ermöglichen, wird ein spezielles Verfahren zur Modellierung fehlender altersgruppenspezifischer Prävalenzen angewendet. Hierzu werden die geschlechtsspezifischen Prävalenzverläufe der AOK-Population entlang der 5-Jahres-Altersgruppen (Rohdaten) auf die (zusammengefassten) Altersklassen der Hochrechnung übertragen und anschließend die resultierenden Verläufe über eine Spline Regression geglättet (Verwendung eines B-Splines) [39]. Von der Glättung ausgeschlossen wurden jene Punktschätzer, die über das Morbiditätsadjustierungsverfahren spezifisch für eine 5-Jahres-Alters-

Health Monit. 2025;10(3):e13412. doi: 10.25646/13412

*Tabelle 1: Aufgreifkriterien zur Definition der Prävalenz von Schlaganfall mit AOK-Routinedaten*

1Stationäre Fälle (301 Abs.1 SGBV): Hauptdiagnose der vollund teilstationären, abgeschlossenen Fälle (Entlassdiagnosen)

vor dem jeweiligen Berichtsjahr verstorben sind, wurden in der Prävalenzberechnung nicht berücksichtigt. Die Aufgreifkriterien beruhen auf ICD-10-GM-kodierten Diagnosen und aus dem stationären Bereich: 162 (Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung) wurde nicht aufgegriffen, da sie sich sowohl im klinischen Bild (den für Schlaganfälle typischen neurologischen Ausfallerscheinungen) als auch durch den geringeren Grad der Beeinträchtigung und die meist folgenlose Ausheilung vom Schlaganfall unterscheidet. Es wurden Fälle in allen Altersgruppen ohne Beschränkungen zur Prävalenzberechnung aufgegriffen und dabei alle Personen der Versichertengrundgesamtheit berücksichtigt. Die Kri-

Es wurde für Schlaganfall adaptiert, um für jedes Berichtsjahr Krankheitshäufigkeiten für die gesamte Bevölkerung Deutschlands auf Ebene der 96 Raumordnungsregionen für Schlaganfall zu schätzen.

Bei der Hochrechnung der Prävalenzen werden aus Gründen der Modellstabilität einzelne Altersgruppen in breitere Altersklassen zusammengefasst, sodass nicht immer eine Prävalenz für jede 5-Jahres-Altersgruppe vorliegt. Um eine Stratifizierung auf dieser Detailebene zu ermöglichen, wird ein spezielles Verfahren zur Modellierung fehlender altersgruppenspezifischer Prävalenzen angewendet. Hierzu werden die geschlechtsspezifischen Prävalenzverläufe der AOK-Population entlang der 5-Jahres-Altersgruppen (Rohdaten) auf die (zusammengefassten) Altersklassen der Hochrechnung übertragen und anschließend die resultierenden Verläufe über eine Spline Regression geglättet (Verwendung eines B-Splines) [39]. Von der Glättung ausgeschlossen wurden jene Punktschätzer, die über das Morbiditätsadjustierungsverfahren